

MEDSHIFT | SPRINT 2

Planejamento dos blocos de desenvolvimento

User Stories US07 a US15

Organização funcional, dependências, prioridades e resultados esperados para a evolução do sistema de escala médica.

Informações do documento

Autor: Arthur Peres da Rocha

Status atual: US07 e US08 concluídas

Visão geral do desenvolvimento

A Sprint 2 foi organizada em quatro blocos sequenciais. Cada bloco entrega uma capacidade utilizável e prepara os dados necessários para o próximo.

Bloco	Foco	User Stories	Prioridade
1	Cadastro e consulta da equipe	US07, US08 e US09	1 a 3
2	Construção e validação da escala	US10 e US11	4 e 5
3	Análise da cobertura dos turnos	US12 e US13	6 e 7
4	Indicadores e resumo da escala	US14 e US15	8 e 9

Sequência lógica

Cadastrar e consultar profissionais, construir a escala, validar a cobertura e apresentar indicadores consolidados.

Bloco 1: Cadastro e consulta da equipe

Objetivo

Criar a base de profissionais que será utilizada por todas as outras funcionalidades do sistema.

US07: Cadastro de profissionais

Como coordenador de escala, quero cadastrar os profissionais da equipe médica, para que eles possam ser utilizados na construção da escala do dia.

Situação: CONCLUÍDA

Prioridade: 1, muito alta

Justificativa: Todas as outras funcionalidades dependem dos profissionais cadastrados.

US08: Listagem de profissionais

Como coordenador de escala, quero visualizar a lista de todos os profissionais cadastrados, para ter uma visão geral da equipe médica disponível.

Situação: CONCLUÍDA

Prioridade: 2, muito alta

Justificativa: Permite conferir se os cadastros foram armazenados corretamente.

US09: Localização por ID

Como coordenador de escala, quero localizar um profissional pelo identificador numérico, para consultar rapidamente seus dados.

Situação: PRÓXIMA

Prioridade: 3, alta

Justificativa: A busca pelo ID será necessária para selecionar um profissional e atribuí-lo a um turno.

Ordem do bloco

- 1 US07: Cadastrar profissionais
- 2 US08: Listar profissionais
- 3 US09: Buscar profissional por ID

Resultado esperado

- Cadastrar profissionais.
- Gerar um ID automático.
- Listar todos os profissionais cadastrados.
- Localizar um profissional específico pelo ID.

Bloco 2: Construção e validação da escala

Objetivo

Permitir que o coordenador selecione um profissional cadastrado e atribua esse profissional a um turno, evitando erros de escalação.

US10: Atribuição de profissional ao turno

Como coordenador de escala, quero atribuir um profissional cadastrado a um turno do dia, para construir a escala médica.

Situação: PENDENTE

Prioridade: 4, alta

Dependências: US07 e US09

Justificativa: O profissional precisa estar cadastrado e ser localizado antes de receber um turno.

US11: Validação da escalação

Como coordenador de escala, quero que o sistema valide cada tentativa de escalação, para impedir conflitos e atribuições incorretas.

Situação: PENDENTE

Prioridade: 5, muito alta

Dependências: US10

Justificativa: Evita que dados incorretos sejam adicionados à escala.

Validações da US11

- O ID informado existe.
- O turno informado é válido.
- O profissional já está escalado no mesmo turno.
- O profissional está disponível para o turno.
- O profissional já atingiu algum limite definido de plantões.
- Existe espaço disponível no turno.
- A especialidade do profissional é válida.

Ordem do bloco

- 1 US10: Atribuir profissional ao turno
- 2 US11: Validar a tentativa de escalação

Resultado esperado

- Localizar o profissional pelo ID.
- Selecionar Manhã, Tarde ou Noite.
- Atribuir o profissional ao turno.
- Impedir escalas duplicadas ou incorretas.
- Informar claramente o motivo de uma tentativa inválida.

Embora a US11 venha depois da US10 na ordem funcional, ela deve ser implementada junto da atribuição. O sistema não deve aceitar uma escalação antes de realizar as validações.

Bloco 3: Análise da cobertura dos turnos

Objetivo

Verificar se a escala construída atende à quantidade mínima de profissionais em todos os turnos.

US12: Validação da cobertura dos três turnos

Como coordenador de escala, quero validar a cobertura dos três turnos do dia, para saber se Manhã, Tarde e Noite possuem a quantidade mínima necessária de profissionais.

Situação: PENDENTE

Prioridade: 6, alta

Dependências: US10 e US11

Justificativa: A cobertura só pode ser analisada depois que os profissionais forem corretamente escalados.

US13: Identificação das coberturas insuficientes

Como coordenador de escala, quero saber quais turnos e quais especialidades estão com cobertura insuficiente, para identificar os problemas existentes na escala do dia.

Situação: PENDENTE

Prioridade: 7, alta

Dependências: US12

Justificativa: Complementa a validação geral, explicando exatamente por que determinado turno foi reprovado.

Regras de cobertura

- 2 Clínicos Gerais
- 1 Pediatra
- 1 Cirurgião

A análise será realizada separadamente para Manhã, Tarde e Noite.

Ordem do bloco

- 1 US12: Verificar a cobertura dos três turnos
- 2 US13: Mostrar turnos e especialidades insuficientes

Resultado esperado

- Informar se Manhã, Tarde e Noite possuem cobertura adequada.
- Indicar quais especialidades estão insuficientes.
- Mostrar quantos profissionais faltam em cada especialidade.
- Informar se a escala do dia pode ser considerada completa.

Bloco 4: Indicadores e resumo da escala

Objetivo

Apresentar uma visão consolidada da distribuição dos plantões e da situação geral da escala.

US14: Quantidade de plantões por profissional

Como coordenador de escala, quero visualizar quantos plantões foram atribuídos a cada profissional, para acompanhar a distribuição dos plantões da equipe.

Situação: PENDENTE

Prioridade: 8, média

Dependências: US10 e US11

Justificativa: Precisa das atribuições realizadas para contabilizar os plantões.

US15: Resumo geral da escala

Como coordenador de escala, quero receber um resumo geral da escala do dia, para compreender rapidamente a situação dos três turnos e dos profissionais.

Situação: PENDENTE

Prioridade: 9, média

Dependências: US12, US13 e US14

Justificativa: É a funcionalidade final, pois reúne os resultados produzidos pelas outras User Stories.

Informações recomendadas para a US15

- Total de profissionais cadastrados, escalados e não escalados.
- Profissionais escalados pela manhã, tarde e noite.
- Quantidade de Clínicos Gerais, Pediatras e Cirurgiões em cada turno.
- Situação da cobertura de cada turno.
- Especialidades com cobertura insuficiente.
- Quantidade de plantões atribuídos a cada profissional.
- Situação geral da escala do dia.

Ordem do bloco

- 1 US14: Contar os plantões de cada profissional
- 2 US15: Apresentar o resumo geral

Resultado esperado

- Visualizar como os plantões estão distribuídos.
- Identificar quem recebeu mais ou menos plantões.
- Ver quais turnos estão completos.
- Ver quais turnos ainda precisam de profissionais.
- Compreender a situação geral da escala médica.

Ordem geral de prioridade

Prioridade	User Story	Descrição resumida	Situação
1	US07	Cadastrar profissionais	Concluída
2	US08	Listar profissionais	Concluída
3	US09	Buscar profissional por ID	Próxima
4	US10	Atribuir profissional ao turno	Pendente
5	US11	Validar tentativa de escalação	Pendente
6	US12	Validar cobertura dos três turnos	Pendente
7	US13	Identificar insuficiências	Pendente
8	US14	Contar plantões por profissional	Pendente
9	US15	Exibir resumo geral da escala	Pendente

Próximo passo recomendado

Desenvolver a US09, pois a localização por ID permitirá reutilizar o profissional cadastrado na construção e validação da escala.